TREINAMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

2023

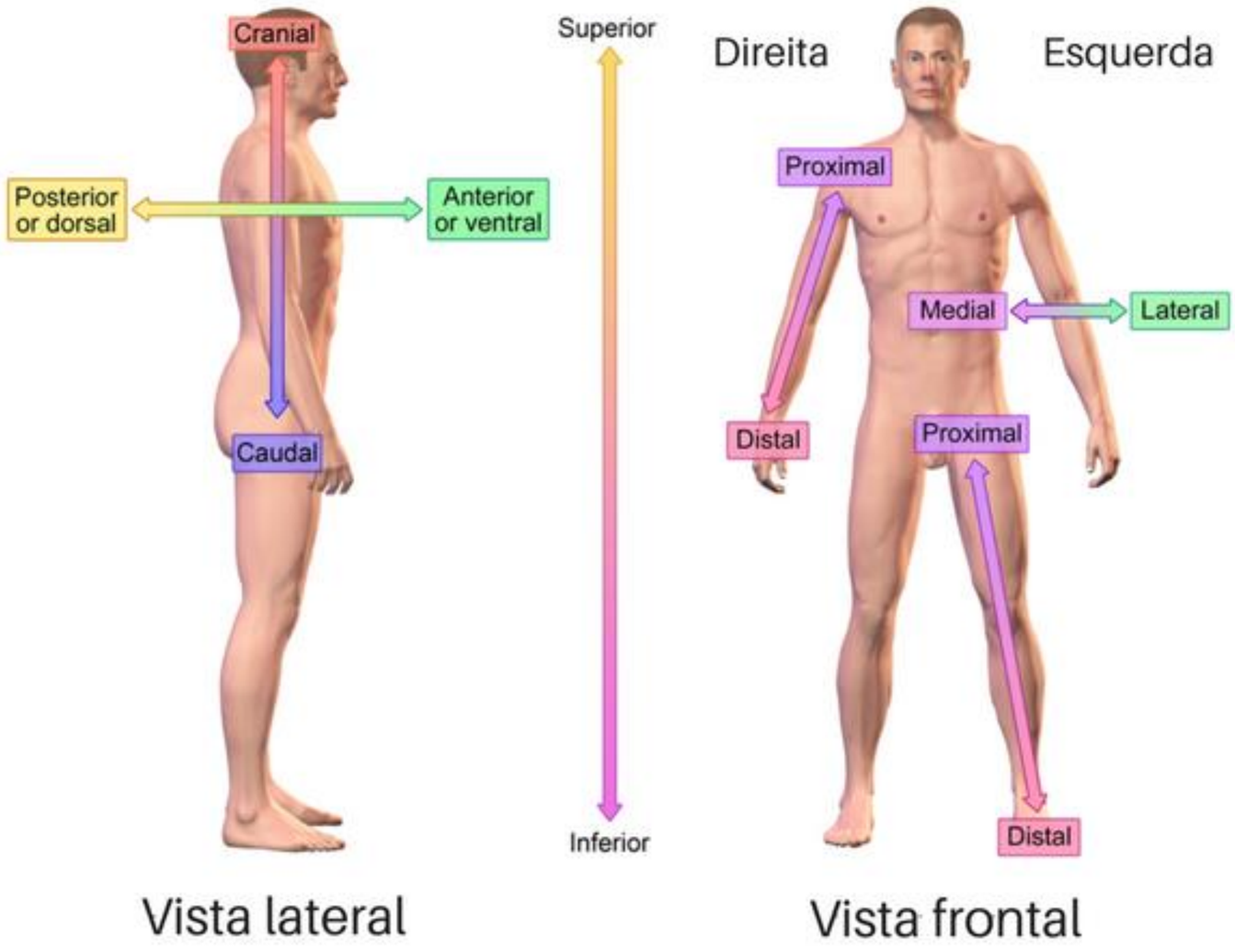
OBJETIVOS DO TREINAMENTO

- ✓**Avaliação inicial:** avaliação básicas de primeiros socorros.
- ✓**Vias aéreas:** causas de obstrução e liberação - Conhecer os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e inconscientes;
- ✓**RCP (reanimação cardiopulmonar):** ventilação artificial e compressão cardíaca externa - Conhecer as técnicas de RCP para adultos, crianças e bebês;

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

- Avaliação inicial
- Vias aéreas
- RCP

REFERÊNCIA ANATÔMICA



Sinais vitais

São as medidas das mais básicas funções do corpo.

Temperatura

Pressão arterial

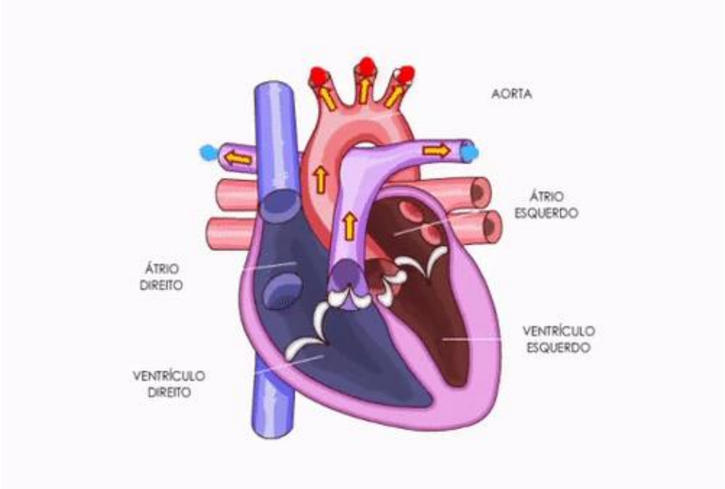
Respiração

Pulso

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

PRESSÃO ARTERIAL (PA)

PA Sistólica (mmHg)	PA Diastólica (mmHg)	Classificação
< 130	< 85	Normal
130-139	85-89	Normal limítrofe
140-159	90-99	Hipertensão leve
160-179	100-109	Hipertensão moderada
> 180	> 110	Hipertensão grave



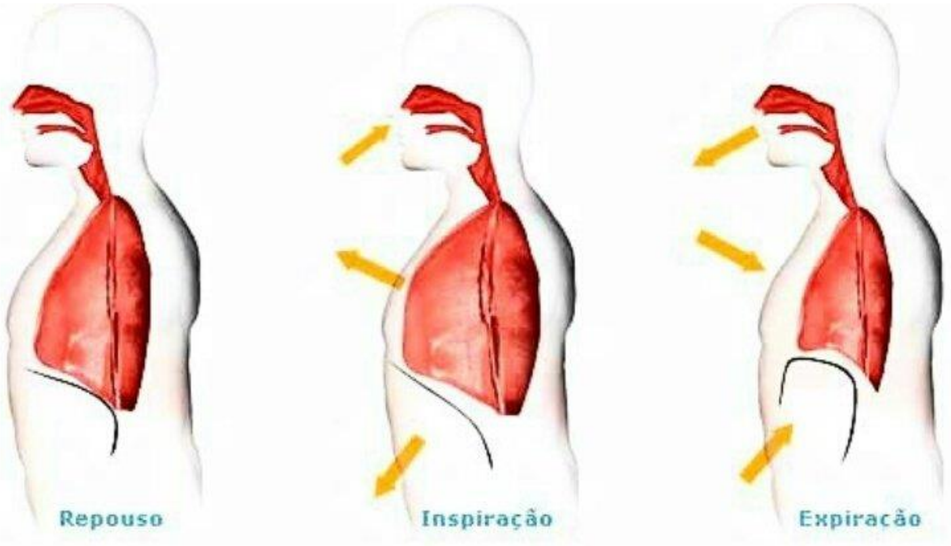
PA - Parâmetro Normal	Criança/Bebê
Sistólica	80 + 2 x idade
Diastólica	⅔ da Sistólica

PULSO (BPM – BATIMENTOS POR MINUTO)

Adulto	Criança	Neonato/Bebê
60 a 100	75 a 140	120 a 160

RESPIRAÇÃO (IRM – INCURSÕES RESPIRATÓRIAS POR MINUTO)

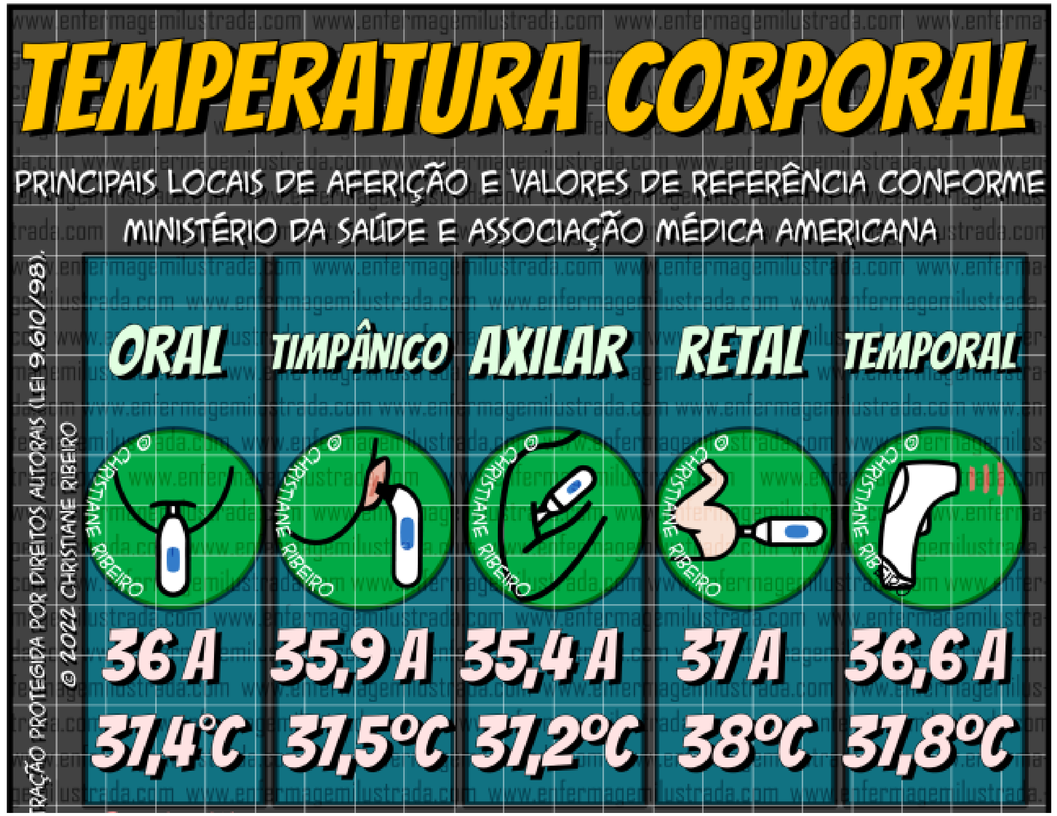
Adulto	Criança	Bebê	Neonato
12 a 20	20 a 32	30 a 50	30 a 60



ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

TEMPERATURA (GRAUS CELSIUS ºC)

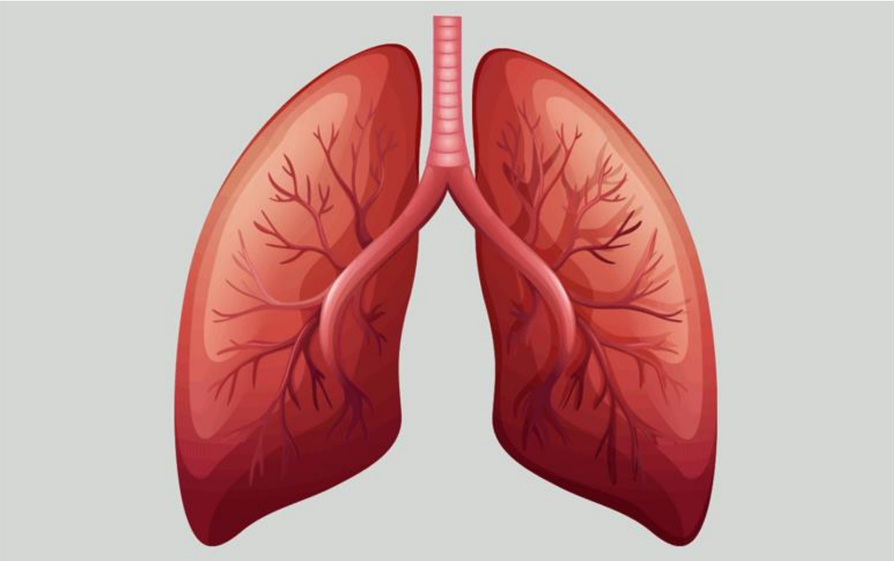
Hipotermia	Normal	Febre Discreta	Febre Moderada	Febre Elevada	Hiperpirexia
< 35 º C	36,6º a 37,2º C	37,3º a 38,4º C	38,5º a 39,0º C	39,1º a 40,5º C	>40,5º C

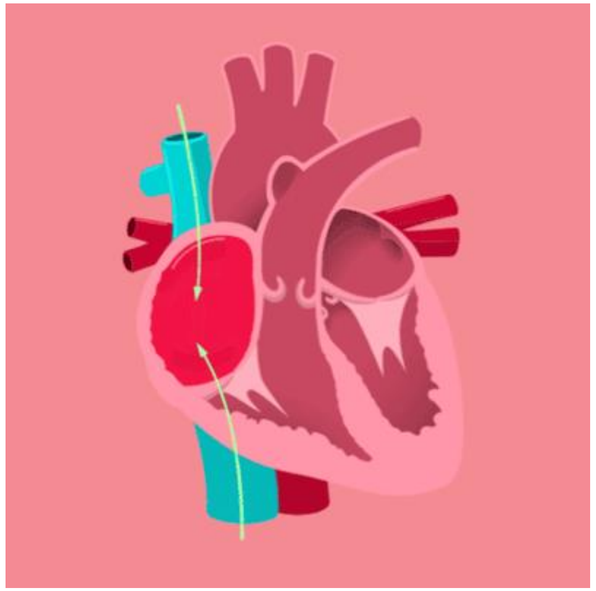


PERFUSÃO CAPILAR

É HORA DA PRÁTICA! VAMOS?

Faça a mensuração dos parâmetros respiratórios.

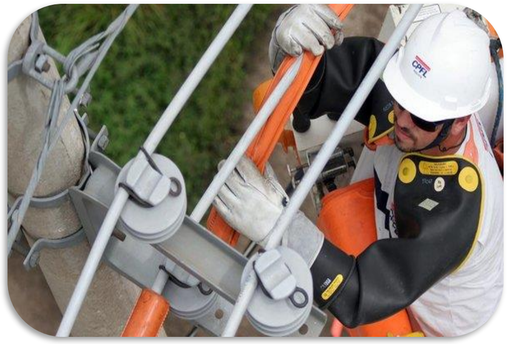




Localize e mensure os parâmetros circulatórios (pulso e perfusão).

Segurança da Cena

- 193 – Bombeiro Militar
- 192- SAMU
- 190 – Polícia Militar
- 197 – Polícia Civil



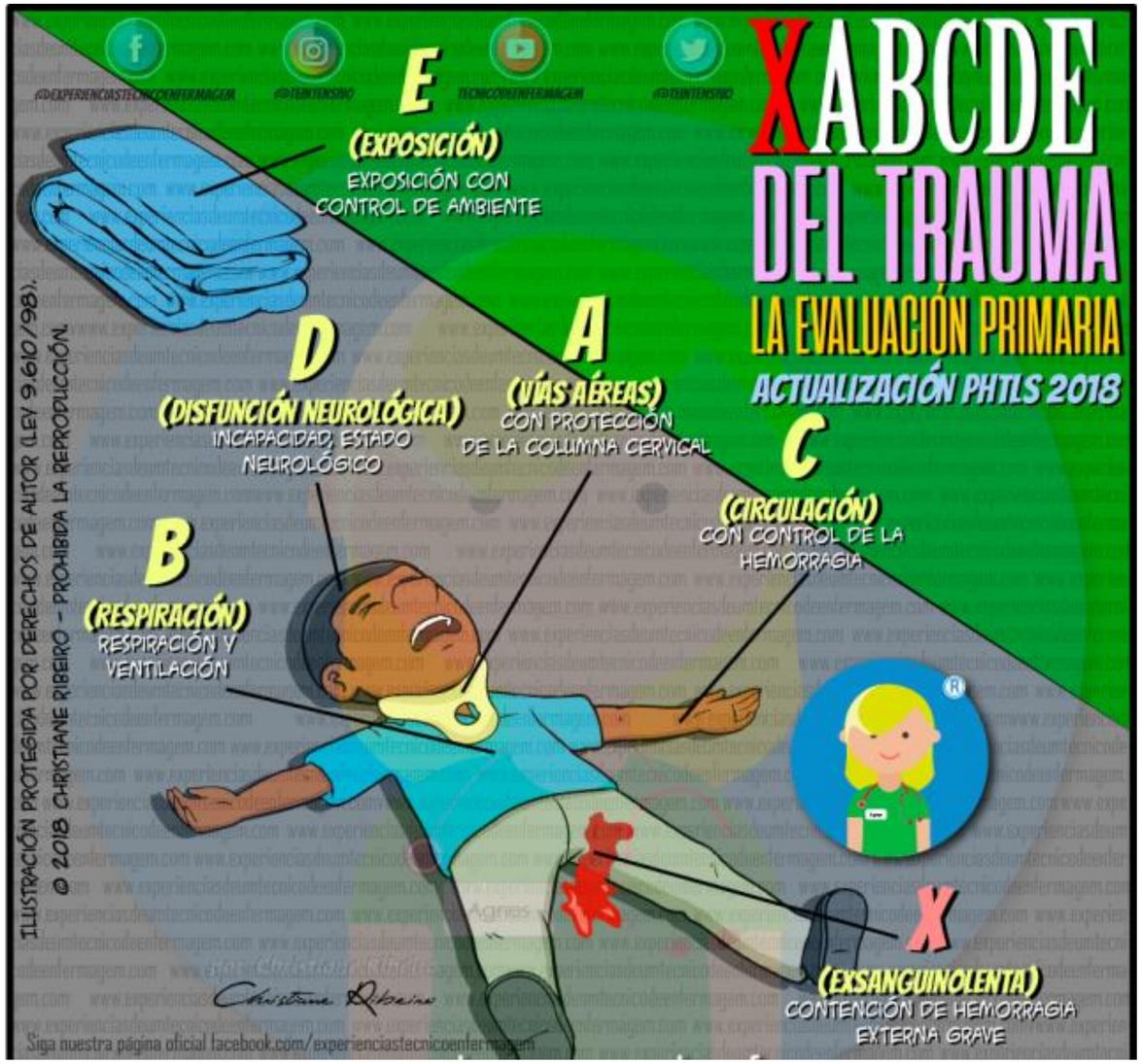
Avaliação Primária Do Paciente - Responsivo

Impressão geral do paciente

- ✓ **Rápida avaliação visual da aparência;**
- ✓ **Boa respiração e cor do paciente;**
- ✓ **Conferência do nível de consciência.**

Avaliação Primária Do Paciente - Responsivo

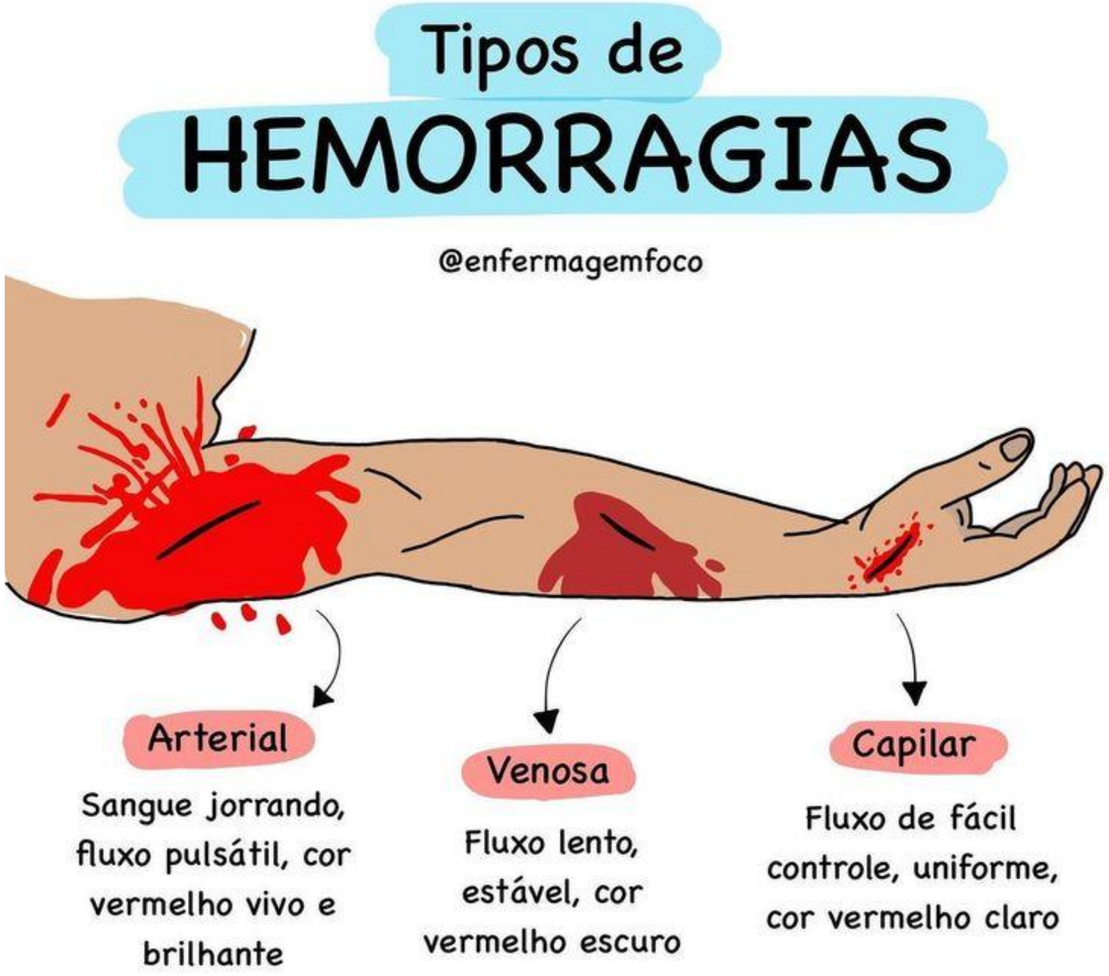
- **X** – hemorragia exsanguinante (controle do sangramento externo grave);
- **A** – vias aéreas e estabilização da coluna cervical;
- **B** – respiração – *breathing* (ventilação e oxigenação);
- **C** – circulação (perfusão e outras hemorragias);
- **D** – disfunção neurológica;
- **E** – exposição ao ambiente.



Avaliação Primária Do Paciente - Responsivo

Etapa X: Hemorragias exsanguinantes (graves)

Controle de hemorragias externas exsanguinantes que ameaçam a vida do paciente.



Avaliação Primária Do Paciente - Responsivo

Etapa A: Abertura de vias aéreas com estabilização da coluna cervical

Se o mecanismo da lesão é significativo, mantenha a estabilização da coluna cervical do paciente.

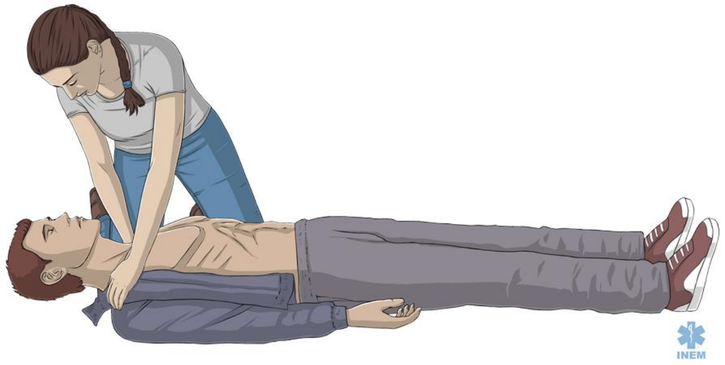
Se paciente irresponsivo, assuma as seguintes manobras de liberação de vias aéreas:

- ✓ **Pacientes clínicos:** manobra de hiperextensão da coluna cervical e elevação do mento (chin lift)
- ✓ **Pacientes de trauma ou natureza de lesão desconhecida:** estabilize a coluna cervical, realizando a anteriorização da mandíbula (jaw thrust) e elevação do mento (chin lift).

Avaliação Primária Do Paciente – Responsivo – ETAPA (A)

Avaliação Primária Do Paciente – Responsivo – ETAPA (A)

- ✓ Verifique o nível de consciência do paciente; se necessário, realize estímulo doloroso.
- ✓ Solicite ao paciente que abra a boca. Em seguida, inspecione, visualmente, as vias aéreas superiores.
- ✓ Posicione o oxímetro no dedo do paciente, avalie a oximetria e administre oxigênio, se necessário.



Avaliação Primária Do Paciente - Responsivo

Etapa B: Ventilação (Respiração)

Exponha o tórax do paciente, faça a inspensão visual e avalie a qualidade de:

- ✓ **PROFUNDIDADE** – superficial, normal ou profunda;
- ✓ **FREQUÊNCIA** – lenta, normal ou rápida;
- ✓ **ESFORÇO** – presente ou ausente;
- ✓ **BILATERALIDADE** – expansão simétrica ou assimétrica;

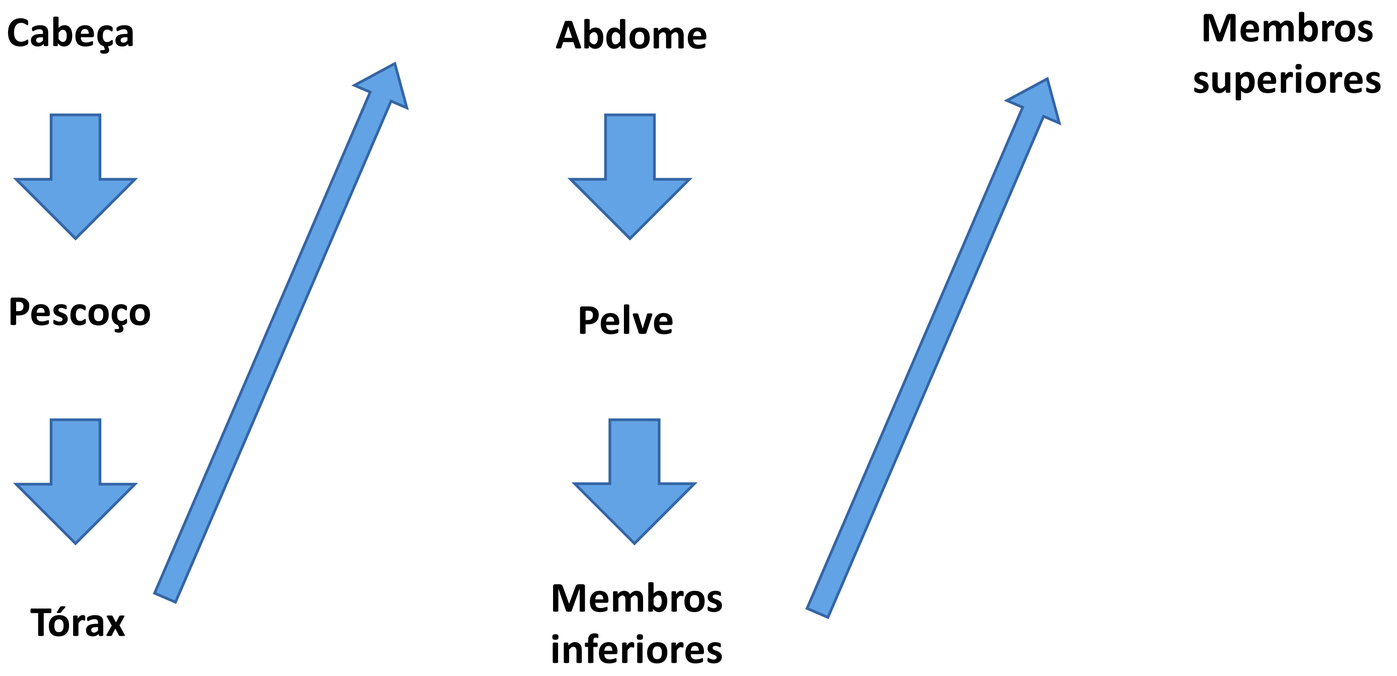
Avaliação Primária Do Paciente – Responsivo – ETAPA (D)

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

Parâmetro	Critério	Resposta - Adulto	Resposta < 2 anos	Pontos
Abertura ocular	Olhos abertos previamente à estimulação	Espontânea	Espontânea	4
	Abertura ocular após estimulação com tom de voz normal ou em voz alta	Ao som	Ao chamado	3
	Abertura ocular após estimulação com pressão no trapézio	À estimulação	À estimulação	2
	Ausência persistente de abertura ocular, sem fatores de interferência	Ausente	Ausente	1
	Olhos fechados devido a fator local	Não testável	Não testável	Não testável
Resposta Verbal	Resposta adequada acerca do local e data	Orientada	Interage, balbucia, segue objetos	5
	Resposta não orientada, mas comunicação coerente	Confusa	Choro, irritação	4
	Palavras isoladas inteligíveis	Palavras	Choro à estimulação	3
	Apenas gemidos	Sons	Gemido à estimulação	2
	Ausência de resposta audível, sem fatores de interferência	Ausente	Ausente	1
	Fator que interfere na comunicação	Não testável	Não testável	Não testável
Resposta Motora	Cumprimento de ordens de duas ações	Às ordens	Movimentos espontâneos	6
	Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo na cabeça ou pescoço	Localizada	Retira ao toque	5
	Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominantemente normal	Flexão normal	Retira à estimulação	4
	Flexão do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominantemente anormal	Flexão anormal	Flexão anormal à estimulação	3
	Extensão do membro superior ao nível do cotovelo	Extensão	Extensão anormal à estimulação	2
	Ausência de movimentos dos membros inferiores/superiores, sem fatores de interferência	Ausente	Ausente	1
	Fator que limita a resposta motora	Não testável	Não testável	Não testável

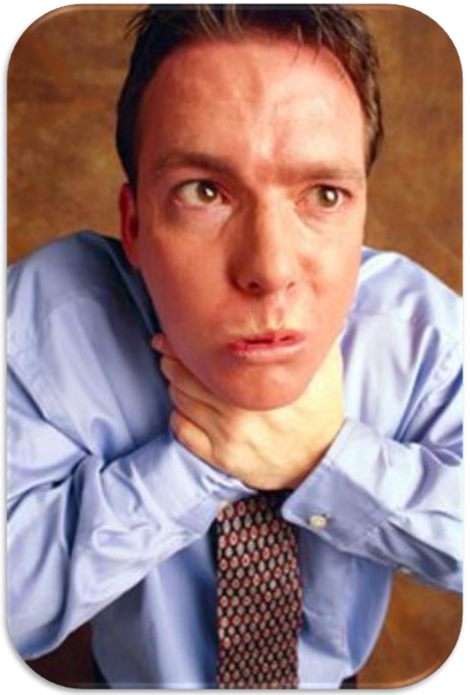
Avaliação Secundária – Exame Físico Detalhado

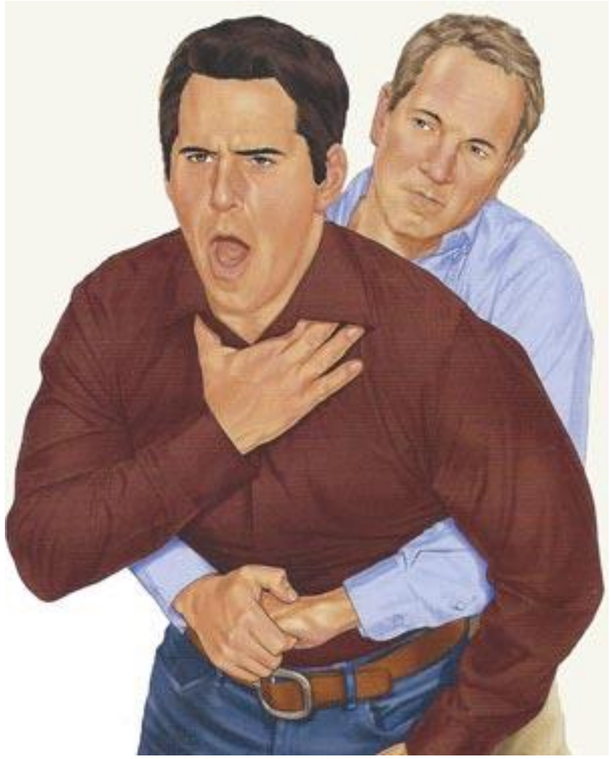
(Inspecione e Apalpe)



Vias aéreas: causas de obstrução e liberação

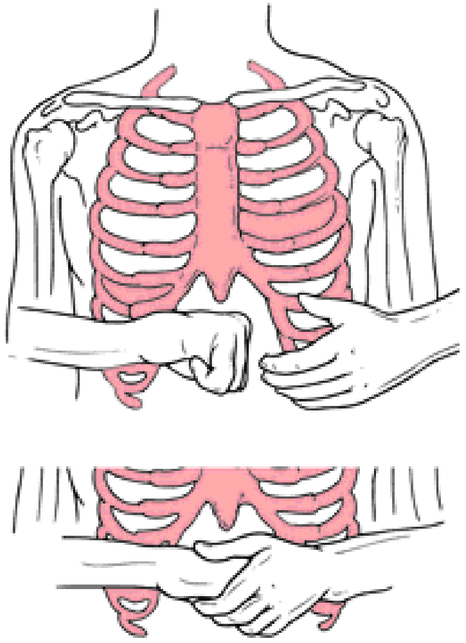
OVACE – Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho





Vias aéreas: causas de obstrução e liberação

Manobra de Heimlich (Compressões em J) – Adultos e crianças

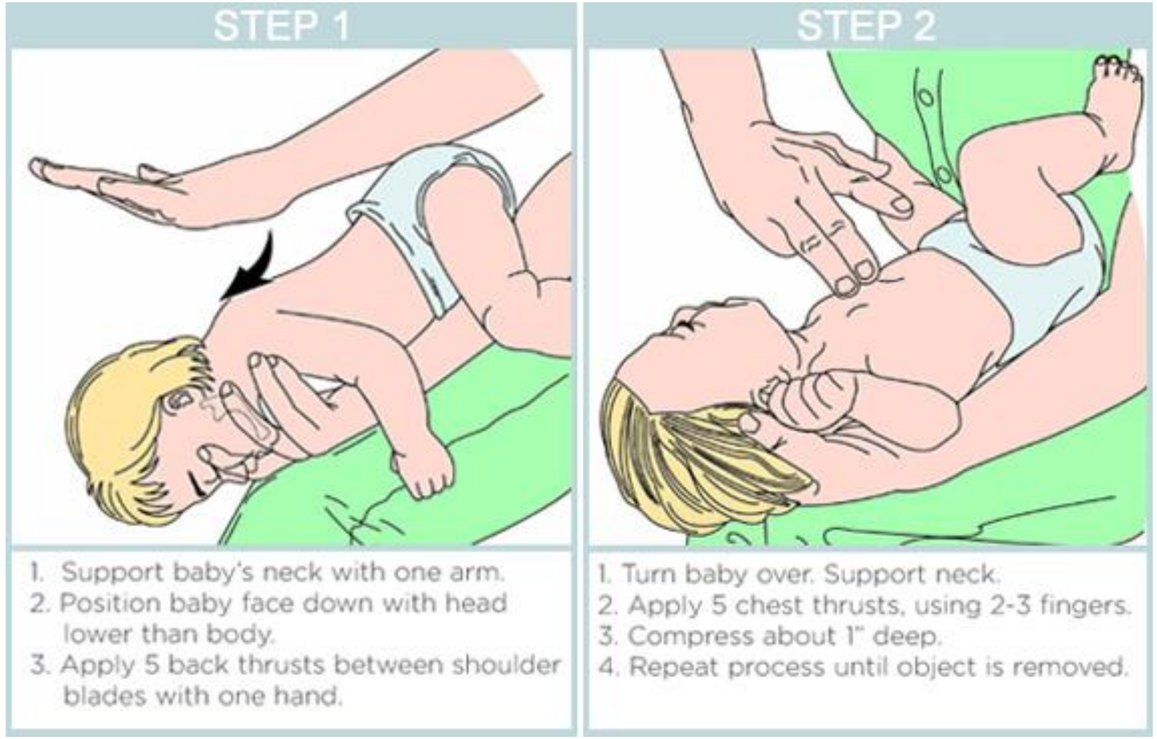


Heimlich with Adult

Heimlich with Child

Vias aéreas: causas de obstrução e liberação

Manobra de desobstrução em bebês



Suporte Básico de Vida (SBV)

Faixas Etárias:

- ✓ **Neonato:** recém-nascido, dos primeiros minutos até a alta da maternidade.
- ✓ **Lactente:** bebê que teve alta da maternidade até 1 ano.
- ✓ **Criança:** de 1 ano até a puberdade (surgimento de pelos pubianos e axilares e broto mamário).
- ✓ **Adulto:** da puberdade em diante.

Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Respiratória (Tem Pulso, mas não Respira):

PARADA RESPIRATÓRIA Frequência de ventilações e ciclos		
PACIENTE	VIA AÉREA COMUM	VIA AÉREA AVANÇADA
Neonato	aperta/solta/solta/aperta 40 a 60 ventilações / min	aperta/solta/solta/aperta 40 a 60 ventilações / min
Lactente	1 vent X 3 seg X 2 min	1 vent X 3 seg X 2 min
Criança	1 vent X 3 seg X 2 min	1 vent X 3 seg X 2 min
Adulto	1 vent X 5 seg X 2 min	1 vent X 6 seg X 2 min

Denomina-se parada respiratória ou paragem respiratória a ausência de fluxo de ar nos pulmões, por ausência de movimentos respiratórios, seja pelo colapso dos pulmões, paralisia do diafragma ou outras causas. Geralmente coincide, é precedida ou leva a parada cardíaca. É uma emergência médica.

Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Cardiorrespiratória (Ausência de Pulso e Respiração):

Parada cardiorrespiratória (PCR) **é a interrupção inesperada e abrupta do trabalho cardíaco e da respiração, com consequente perda da consciência**. O que se observa na maioria desses casos é que o evento não acontece por acaso, ele é o resultado da evolução de doenças de base.

Aborde e identifique a PCR (não respira e não tem pulso), conforme Avaliação Primária, porém sem inserção da cânula ao observar a inconsciência.
O foco do socorrista sozinho é identificar a PCR e iniciar as compressões.

Inicie o procedimento de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), executando 30 compressões torácicas.

Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Cardiorrespiratória (Ausência de Pulso e Respiração):

.

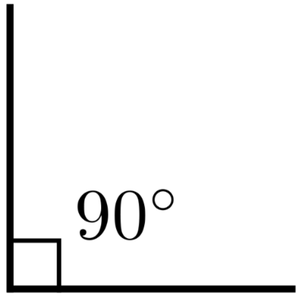
Identificou ausencia de pulso, NÃO respira (tórax não expande) Inicie a RCP,
executando compressões 100 a 120 por minutos , revezando a cada 2 minutos para garantir uma compressão eficaz;
Solicite que alguém acione socorro 192.

Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Cardiorrespiratória (Ausência de Pulso e Respiração):

.

Braços do socorrista



Superfície

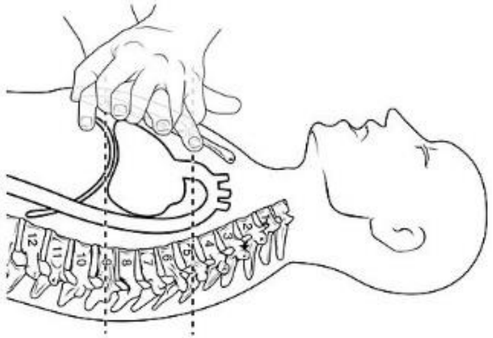
Cotovelos estendidos

Permitir o retorno do tórax

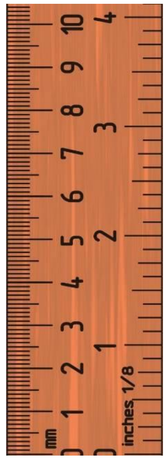
Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Cardiorrespiratória (Ausência de Pulso e Respiração):

Frequência mínima de 100 a 120 compressões por minuto

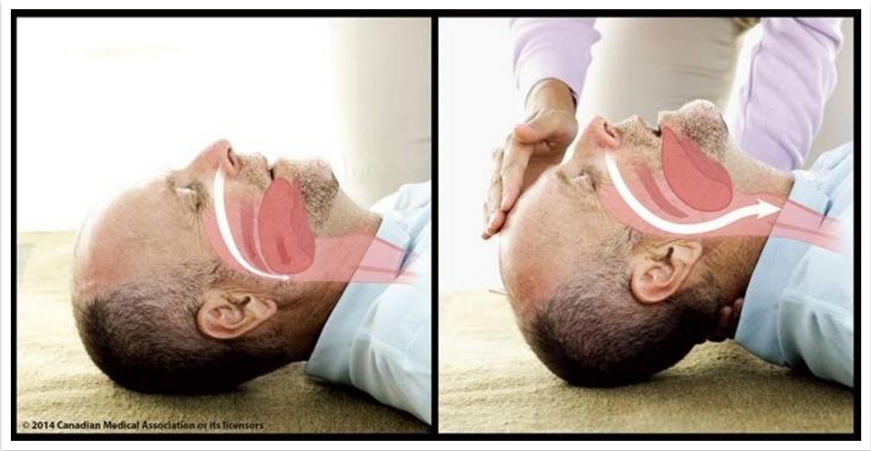


Depressão de 5 a 6 cm



Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Cardiorrespiratória (Ausência de Pulso e Respiração):



.

VENTILAÇÕES:

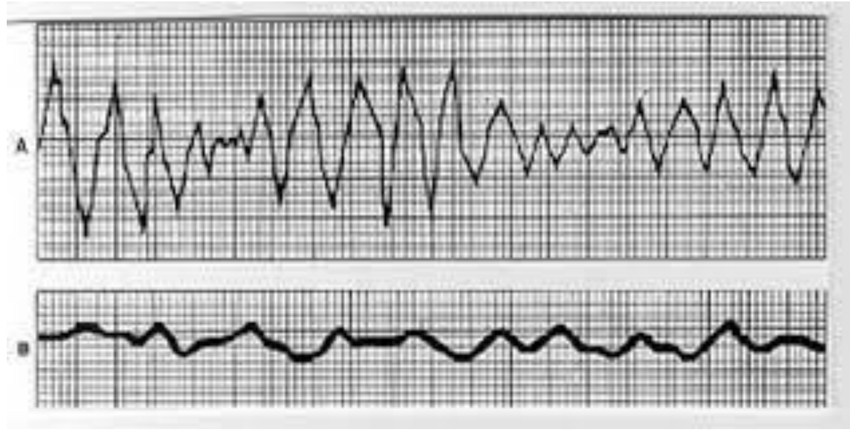
1 segundo de duração, com expansão visível do tórax

Suporte Básico de Vida (SBV)

Parada Cardiorrespiratória (Ausência de Pulso e Respiração):

Suporte Básico de Vida (SBV)

Desfibrilador Externo Automático (DEA):



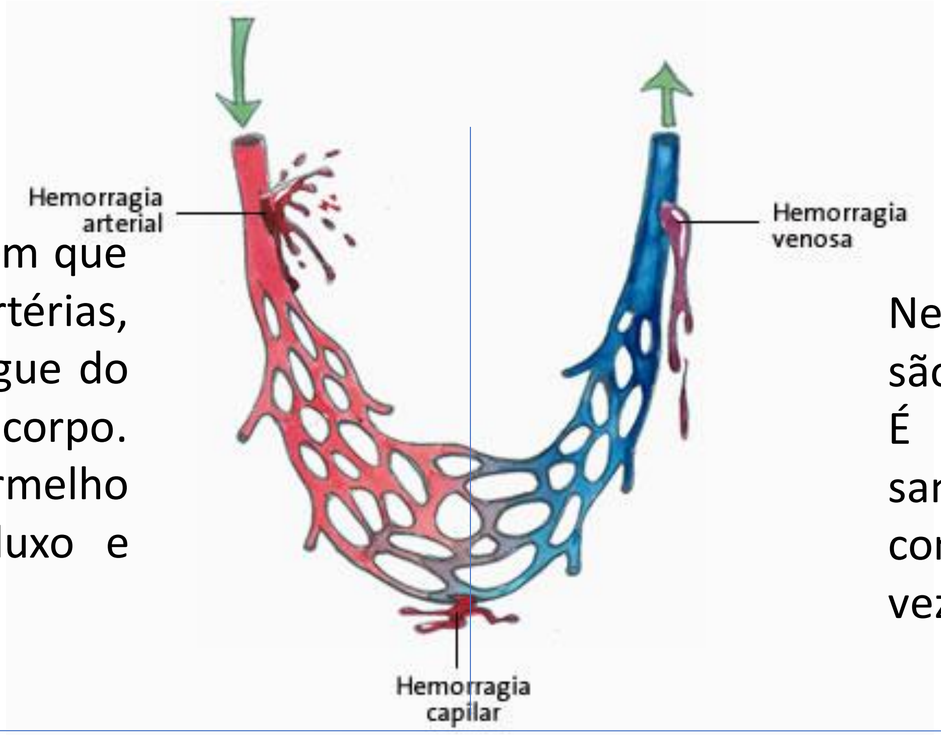
É HORA DA PRÁTICA! VAMOS?

Hemorragia

É a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria, alterando o fluxo normal da circulação podendo ser interna ou externa.

ARTERIAL

Tipo de hemorragia em que são atingidas as artérias, vasos que levam sangue do coração ao resto do corpo. Possui sangue vermelho vivo, com grande fluxo e intensidade.



VENOSA

Neste tipo de hemorragia são acometidas as veias. É caracterizada por ter sangramento em fluxo contínuo e lento, por vezes de grande volume.

CAPILAR

Apenas os pequenos vasos que chegam até a superfície do corpo, chamados de capilares, são atingidos.

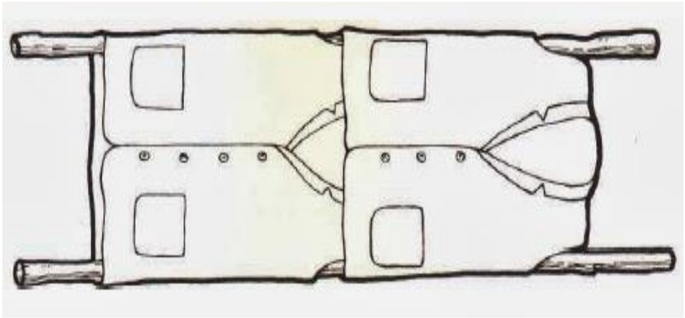
Movimentação, remoção e transporte de vítimas.

Atentar-se caso houver trauma na coluna cervical!

- Prancha longa;
- Cadeiras de rodas;
- Macas;
- Macas tipo colher;
- Sked;
- Chave de rauteck;
- Maca padiola.

Foto 2 Manobra Chave de Rauteck

Fonte: Goiás, 2016



"QUALQUER LUGAR É SEGURO
QUANDO ESTAMOS DEBAIXO
DA VONTADE DE DEUS."